

Amœbose (amibiase)

I- Introduction :

- **Parasitose**, largement répandue dans les pays sous-développés
- Maladie du péril fécal
- Cliniquement : amœbose **colique/ hépatique**.
- TRT : imidazolés
- Déclaration obligatoire.
- Prévention : respect des règles d'hygiène

II- Épidémiologie :

1. **Agent causal** : Entamoeba histolytica, protozoaire parasite du **colon** humain.
On en distingue deux aspects :
 - . **Trophozoïte** : forme végétative mobile et de multiplication, présente deux formes :
 - Entamoeba histolytica minuta commensale de l'intestin
 - Entamoeba histolytica histolytica à pouvoir invasif pathogène.
 - . **Kyste** : immobile, forme de résistance et de contamination.
2. **Réservoir naturel** :
 - L'homme est le seul réservoir du parasite.
 - Entamoeba histolytica est éliminé dans les selles des sujets parasités sous forme **kystique** très résistante.
 - Les kystes survivent plusieurs semaines en milieu extérieur humide.
3. **Transmission** :
 - Péril fécal+++
 - Indirecte : eaux ou aliments souillés (maladie à transmission hydrique).+++
 - Directe : maladie des mains sales.
4. **Modalités épidémiologiques** :
 - Cosmopolite,
 - Sévit à l'état endémique dans les pays en voie de développement (dont l'Algérie).
 - Dans les pays développés, il s'agit d'une maladie d'importation.

III- Physiopathologies :

• **Amœbose infestation** :

kystes ingérés → Entamoeba histolytica minuta (saprophyte de la lumière colique) → asymptomatique.

Seules certaines souches auraient une pathogénicité potentielle → invasives

• **Amœbose maladie** : Entamoeba histolytica histolytica (souches invasives).

Les conditions du passage de l'amœbose infestation à amœbose maladie sont mal élucidées.

• **Amœbose maladie** :

-EHH envahit la paroi colique

-Portions **cæcale, sigmoïdienne et rectale**

-ulcérations → microhémorragies → **tableau de dysenterie non fébrile**.

-EHH peuvent migrer par voie **portale** vers le foie (**amœbose hépatique**) : une nécrose tissulaire à l'origine d'abcès.

-EHH peut franchir le filtre hépatique : amœbose pleuro pulmonaire.

-Tumeurs inflammatoires coliques (**amœbomes**) avec présence d'amibes au sein de la tumeur.

IV- Étude clinique :

- **Amibiase colique** :
 - Forme typique :

- Amœbose colique aiguë ou dysenterie amibienne
- Début : souvent brutal, parfois annoncée par une diarrhée banale ou une douleur abdominale.
- Phase d'état :
- Syndrome dysentérique typique Epreintes+ Ténésme + crachats dysentériques.
- Pas de fièvre ++++
- Epreintes : Douleurs expulsives violentes à type de coliques débutant au niveau de la fosse iliaque droite, parcourant le cadre colique et se terminant par une envie impérieuse d'aller à la selle.
- Ténésmes : Sensation douloureuse de contracture anale ou parfois seulement une sensation de corps étranger intra-rectal. A l'origine d'émission de selles ou de faux-besoins.
- Selles : fréquentes 10-15/jour, typiquement afécales, faites uniquement de glaire muco- purulente et de sang : crachats dysentériques
- **Evolution** : Sous traitement, l'évolution est rapidement favorable.
- **Complications** :
- Hémorragies digestives, perforations coliques, abcès péri colique.
- Localisations tissulaires à distance : amibiase hépatique+++, pleuropulmonaire, cérébrale, péricardique...
- Ameobome : pseudotumeur inflammatoire
- Colite chronique : se manifeste par un syndrome de colopathie fonctionnelle (troubles du transit avec alternance de diarrhée et de constipation, dyspepsie, sensibilité de l'abdomen à la palpation).
- Formes cliniques : forme atténuée, amibiase colique suraiguë ou maligne.
- **Amœbose hépatique** :
- C'est la plus fréquente des localisations extra coliques.

1/ Douleurs lancinantes de l'hypocondre droit, irradiant en bretelle vers l'épaule droite.

Il s'agit d'une douleur spontanée, exacerbée par la palpation et l'ébranlement du foie.

2/ Fièvre élevée à 39 ou 40°C,

3/ Hépatomégalie : Le foie est augmenté de volume, ferme, lisse, douloureux à la palpation avec un bord inférieur moussé.

- Triade de Fonton : Douleur de l'hypocondre droit+ Fièvre élevée+ Hépatomégalie. → amœbose hépatique.
- Parfois, un syndrome **pleuropulmonaire** de la base droite : toux, dyspnée, douleur.
- Rarement est observé un **ictère**, le plus souvent de nature rétentionnelle, suite au développement d'un abcès comprimant la voie biliaire principale.
- Evolution :
- Sous traitement, l'évolution est favorable avec disparition de la fièvre et de la douleur en quelques jours avec régression de l'hépatomégalie.
- Complications : augmentation du volume avec risque de rupture dans les organes de voisinage : plèvre, péricarde, péritoine, voies biliaires et la peau.

V- Diagnostic :

❖ Diagnostic positif :

- **Arguments épidémiologiques** : en Algérie, l'amœbose est endémique
- **Arguments cliniques** :
 - Syndrome dysentérique non fébrile.
 - Dans l'amibiase hépatique : hépatomégalie fébrile et douloureuse avec signes de suppuration profonde.
- **Arguments para cliniques** :

	Amœbose colique	Amœbose hépatique
D'orientation	• pas de modification de l'hémogramme ni des paramètres inflammatoires.	• Hémogramme : hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile. • CRP et VS très élevées.

		• Radiographie thoracique : surélévation de la coupole droite avec comblement du cul de-sac costo-diaphragmatique. • Echographie hépatique : une ou plusieurs formations liquidiennes arrondies, volontiers polylobées, de taille variable. • TDM abdominale : n'est indiquée qu'en cas de forte suspicion clinique lorsque l'échographie n'est pas contributive.
De confirmation	• Examen parasitologique des selles : mise en évidence de formes végétatives d'<i>Entamoeba histolytica</i>. • Rectoscopie (si parasitologie négative) : révèle des ulcérations muqueuses « en coups d'ongle », la biopsie permet de retrouver <i>Entamoeba histolytica</i> au sein des tissus. • Sérologie : n'a pas d'intérêt dans cette forme.	• Recherche des amibes est en règle négative : rare dans les selles, jamais dans les lésions abcédées. • Le diagnostic repose sur la sérologie qui peut ne se positiver qu'après le 7^e jour de fièvre, parfois même plus tardivement.

❖ **Diagnostic différentiel :**

Amœbose colique dysentérique	Amœbose hépatique
• Shigellose : fièvre, altération de l'état général, déshydratation, Dg : coproculture, hémocultures • Colite pseudomembraneuse : prise d'antibiotiques (lincosamide, β-lactamines) • Colite inflammatoire (Recto-colite Ulcéro-Hémorragique) : syndrome inflammatoire, signes extradiigestifs. Diagnostic : histologie	• Abscès à pyogènes : Diagnostic : ponction, examen bactériologique. • Kyste hydatique infecté : Diagnostic : sérologie • Cancer primitif du foie : Diagnostic : biopsie échoguidée, histologie

VI- Traitement :

Curatif :

Moyens : imidazolés

- **Amoebicide diffusible (tissulaire): Métronidazole (Flagyl®) :**

Comprimés 250 mg et 500 mg ampoules IV à 500mg solution buvable

Posologie : 30 mg/kg/j chez l'enfant ; 1,5 à 2 g/j chez l'adulte.

- **Amoebicide de contact (Intetrix®) :**

2 gélules matin et soir pendant 10 jours) pour éviter les rechutes.

Indications :

❖ *Amibiase colique :*

Métronidazole (Flagyl®) par voie orale (PO).

Durée : 7 à 10 jours.

Ce traitement doit être complété par un amoebicide de contact (Intetrix®)

❖ *Amibiase hépatique :*

- Métronidazol PO pendant 7 à 10 jours, Complété par un amoebicide de contact.

-Situation habituelle sous notre climat :

hépatomégalie fébrile et douloureuse est très évocatrice du Dg et justifie un traitement d'épreuve par nitroamydazolés : Métronidazole par voie veineuse, complété par un amoebicide de contact.

Suivi :

- Clinique : fièvre et douleur disparaissent en moins de 3 jours
- Biologique : CRP, VS.
- Echographique : se normalise de façon plus lente (2 à 12 mois), cependant il peut persister une image cicatricielle.

Amibiase hépatique :

- La ponction-drainage écho-guidée de l'abcès n'est pas indispensable dans la majorité des cas, mais se justifie :
 - Volumineux proche de la capsule hépatique avec risque de rupture
 - Eliminer un abcès à pyogène
 - Visée antalgique
 - Evolution défavorable

Prévention :

- Hygiène+++
- Se laver les mains+++
- Boire de l'eau potable contrôlée+++
- Bien laver fruits et légumes+++.
- MDO.